

Strategisch Implementatieplan: Modern Werkgeverschap en de Regionale Arbeidsmarktagenda

1. Strategisch Kader: De Urgentie van een Integrale Arbeidsmarktaanpak

De Nederlandse zorgsector staat voor een existentiële uitdaging. De demografische cijfers zijn onverbiddelijk: waar nu 1 op de 7 werkenden in de zorg actief is, zal dit in 2040 naar verwachting 1 op de 4 moeten zijn om de stijgende zorgvraag op te vangen. Met een huidig geprognosticeerd tekort van 80.000 tot 100.000 banen is de houdbaarheid van het stelsel in het geding. Dit plan fungeert als strategisch kompas om de noodzakelijke transformatie van 'aanbodgestuurde zorg' naar 'passende zorg' te realiseren. De kernproblematiek manifesteert zich op drie niveaus:

- **Macro-niveau (Systeem):** Een onhoudbare mismatch tussen de stijgende zorgvraag door vergrijzing en een beperkt arbeidsaanbod, waarbij de sector dreigt te kannibaliseren op andere vitale publieke sectoren.
- **Meso-niveau (Regio/Sector):** Hoge uitstroomcijfers in kritieke takken zoals de wijkverpleging en jeugdzorg, gecombineerd met een groeiende schaarste aan (gespecialiseerd) mbo- en hbo-personeel.
- **Micro-niveau (Organisatie):** Een verstikkende regeldruk, gebrekkige professionele zeggenschap en een mismatch tussen opleiding en inschaling die de retentie ondermijnt. De transitie naar 'passende zorg' is alleen haalbaar als we de zorgprofessional 'op één' zetten. Dit vraagt om een fundamentele verschuiving naar modern werkgeverschap, waarbij de vijfpuntenagenda van de SER dient als hefboom om abstract beleid om te zetten in meetbare organisatieresultaten.

2. Agendapunt 1: Professionele Ruimte als Fundament voor Kwaliteit

Professionele autonomie is geen gunst van het management, maar een strategische noodzaak. Vertrouwen is de enige weg om de administratieve lastendruk structureel te verlagen. De organisatie moet de regie teruggeven aan de professional om de intrinsieke motivatie en kwaliteit van zorg te borgen. **Definitie van Professionele Ruimte** Op basis van de stem van de professional (Kader 1) definiëren wij deze ruimte als de combinatie van tijd, vertrouwen en eigen regie:

- *"Vertrouwen om zelfstandig keuzes te maken en respect van de werkgever voor mijn keuzes."*
 - *"Tijd om naar mijn patiënten te luisteren en echt na te kunnen denken over diagnose en beleid."*
 - *"Je eigen expertise kunnen benutten, met voldoende autonomie daarvoor."*
- Actieplan: Reductie Administratieve Lasten (Doelstelling: -50%)** Om de professionele ruimte te heroveren, moet de organisatie afscheid nemen van 'beheersingsreflexen'.

1. **Kritisch screenen van interne regelgeving:** Elimineer protocollen die zijn ontstaan na incidenten of uit wantrouwen.
2. **Investeren in professioneel verstandig handelen:** Verschuif de focus van 'protocol-fetisjisme' naar professionele intuïtie en situationele oordeelsvorming.
3. **Lobby voor systeemvertrouwen:** Als bestuurder moet u bij verzekeraars en de Inspectie aandringen op verantwoording op basis van uitkomsten in plaats van

handelingen, aangezien de beoogde 50% reductie alleen haalbaar is als het systeemniveau meebeweegt. Deze autonomie vormt de basis voor een leven lang ontwikkelen, waarbij de professional zelf de koers van zijn groei bepaalt.

3. Agendapunt 2: Strategische Scholing en Regionale Loopbaanpaden

In een krappe markt is scholing de krachtigste retentietool. Ontwikkeling moet verschuiven van diploma-gericht naar competentie- en loopbaangericht. We moeten toe naar een model waarbij we niet voor de eigen organisatie, maar voor de 'regionale vijver'

opleiden. **Regionaal Uitvoeringsmodel Scholing** | Actor | Verantwoordelijkheid & Instrumentarium || ----- | ----- || **Zorgorganisatie** | Invoering van het **Persoonlijk Professioneel Portfolio (PPP)** ; inzet van de **Zorginspirator** -tool voor het erkennen van informele skills. || **Sector / Regio** | Inrichten van regionale leer- en loopbaan-netwerken; faciliteren van horizontale mobiliteit tussen branches (wijk, ziekenhuis, GGZ). || **Overheid / Systeem** | Faciliteren van modulair onderwijs; inrichten van 'vakscholen' (hybride leren-werken); wegnemen van fiscale drempels. |

Strategisch Advies: Barrières Slechten Een kritieke blokkade voor regionale mobiliteit is de btw-problematiek bij detachering. Ik adviseer de Raad van Bestuur om actief deel te nemen aan regionale coalities om gezamenlijk druk uit te oefenen op het Ministerie van Financiën. Zonder het wegnemen van deze btw-last blijft regionale personeelsuitwisseling onnodig duur en complex. Het binden van talent via scholing is echter effectief zolang de 'lekke emmer' aan de achterzijde wordt gedicht door een mensgerichte bedrijfsvoering.

4. Agendapunt 3: Behoud door Modern Werkgeverschap en Onboarding

De strategische impact van de 'lekke emmer' is alarmerend: 27% van de nieuwe instroom verlaat de organisatie binnen het eerste jaar. Dit is een kapitaalvernietiging die we ons niet kunnen veroorloven. **Onboarding & Retentie Protocol**

- **Lange-termijn Coaching:** Elke nieuwe medewerker krijgt minimaal één jaar intensieve begeleiding door een senior coach.
- **Trainee-trajecten:** Faciliteer jonge professionals om in hun eerste jaar diverse afdelingen te verkennen voordat zij zich binden aan één specialisme.
- **Levensfasebewust Personeelsbeleid:** Gezien het feit dat één op de drie zorgmedewerkers mantelzorgtaken heeft, zijn maatwerkroosters en mantelzorgarrangementen geen 'extraatjes' maar harde randvoorwaarden voor behoud. **Preventieve HR-interventies** Door de vertrekredenen (gebrek aan carrièreperspectief, werkstijl, sfeer) proactief te monitoren via 'blijf-gesprekken', kan HR tijdig interveniëren. Modern werkgeverschap betekent dat de organisatie zich aanpast aan de levensloop van de medewerker, in plaats van andersom. Deze erkenning moet echter ook tot uiting komen in de materiële waardering.

5. Agendapunt 4: Waardering, Zeggenschap en Marktconforme Beloning

Er gaapt een kloof tussen de ervaren waardering van collega's (87%) en de waardering vanuit de overheid (36%). Om de zorg aantrekkelijk te houden voor carrièreswitchers, is een concurrerend arbeidsvoorwaardenpakket noodzakelijk. **Marktconforme Beloning en de 'Toeslag-klem'** De eindsalarissen in de zorg (FWG 35-65) lopen 9% achter op de marktsector en 6% op de publieke sector. Er is extra budget vereist om dit gat te dichten. Cruciaal hierbij is de **toeslagen-problematiek** : HR moet medewerkers ondersteunen met de **'WerkUrenBerekenaar'** . Het voorkomen van de armoedeval (waarbij meer werken leidt

tot netto inkomensverlies door het wegvallen van toeslagen) is een essentieel onderdeel van het strategisch retentiebeleid. **Zeggenschap in Governance** Waardering is ook een kwestie van macht.

- **Betekenisvolle zeggenschap:** Veranker de invloed van professionals in de governance code.
- **Bestuurlijke afspiegeling:** Streef naar een Raad van Bestuur waarin zorginhoudelijke expertise (bijv. een verpleegkundige achtergrond) is vertegenwoordigd.
- **Kwaliteit als taak:** Beschouw kwaliteitsontwikkeling als reguliere werktijd, niet als iets voor 'erbij'. Een sterke zeggenschap stelt de professional tevens in staat om technologische innovaties effectief te implementeren.

6. Agendapunt 5: Technologische en Sociale Innovatie (AI-Realisatie)

Technologie is de hefboom voor arbeidsproductiviteit. Het 'Programma Realisatie AI in de zorg' richt zich op het terugbrengen van de administratietijd naar maximaal 20% in 2030. **Kansrijke AI-toepassingen**

- **Spraakgestuurd Rapporteren:** Directe tijdsbesparing en reductie van registratiefrustratie.
- **AI-roosterplanning:** Optimaliseert de balans tussen zorgvraag en de persoonlijke levenssfeer van medewerkers (**Grip op het Leven**).
- **Medische Beeldanalyse:** Verhoogt de diagnostische snelheid en kwaliteit. **Governance en Doorbraakmiddelen** Voor de opschaling is in 2027 en 2028 respectievelijk **400 miljoen euro per jaar** (totaal 800 miljoen) aan doorbraakmiddelen beschikbaar. Om aanspraak te maken op deze middelen is de aanstelling van een **Chief Nursing Information Officer (CNIO)** verplicht. De CNIO slaat de brug tussen techniek en de werkvloer; technologische innovatie faalt immers zonder sociale innovatie en cultuurverandering.

7. Conclusie: De Transitie naar Grip op Geld, Werk en Leven

Dit plan integreert de vijf agendapunten tot een samenhangend kader voor modern werkgeverschap, gestoeld op de drie pijlers van de WRR:

1. **Grip op Geld:** Marktconforme beloning en het actief navigeren van de toeslagen-klem voor economische zelfstandigheid.
2. **Grip op Werk:** Professionele autonomie door het reduceren van protocollen en het verankeren van betekenisvolle zeggenschap.
3. **Grip op het Leven:** Een flexibele organisatie die AI en levensfasebewust beleid inzet om werk en privé (inclusief mantelzorg) in balans te houden. Modern werkgeverschap is de enige houdbare strategie. Ik roep de Raad van Bestuur op om de regie te pakken in het regionale netwerk en de organisatie te transformeren van een systeem van controle naar een cultuur van vertrouwen. De zorgprofessional 'op één' is geen abstract ideaal, maar de enige weg naar kwalitatieve en toegankelijke zorg voor de toekomst.